

Fecha Última Actualización: 17-11-2022 9:34:16

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Eduardo Ivan Andrade Posas

Edad : 82a 11m 4d

Dirección : Rafael Alberty 918

Rut : 4.783.144-K

Fecha Nacto: 12/12/1939

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0612548

Sexo : Masculino

Teléfono : 9 9280 0970

N° Epicrisis

330513

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 08/11/2022 22:50

Días Estadía: 8

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 16/11/2022 17:30

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

EPOC; Diabetes Mellitus 2 Insulino requirente; Demencia; Insuficiencia Renal Crónica;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes mórbido:

- EPOC sin O2 domiciliario

- Enfermedad Renal Crónica (no etapificado, con diuresis conservada).

- DM2 IR

- Demencia

- Quirúrgicos: Hernioplastia, colecistectomía, circuncisión.

- Fármacos: Citalopram 20, donepezilo 5, memantina 10, omeprazol 20, insulina nph 42-0, glargina 12 preprandial, brexotide 2 c/12, SABA SOS, B ipratropio 2 c/8.

- Alergias: (-)

- Hábitos: TBQ (+), OH (-), Drogas (-)

- Hospitalizaciones: Octubre 11/10 por exacerbación EPOC en UHD, 25-27/10 en UTIM por exacerbación de EPOC.

- Social: Vive con hijo, Manuel.

Anamnesis próxima:

Paciente con antecedente de EPOC exacerbado manejado en UHD CASR con oxigenoterapia y ATB ceftriaxona. Completó 10 días de tratamiento y fue dado de alta el 21/10.

El 24/10 consulta en SU CASR por cuadro clínico caracterizado por compromiso del estado general, tos con expectoración no mucopurulenta y peak febril hasta 38.4°C. Al ingreso, paciente HD estable, saturando 85% ambiental, en sopor superficial y desorientado TE, MP disminuido difusamente, roncus y estertores a derecha. En laboratorio de ingreso, hipercarbica y parámetros inflamatorios elevados. Sin microbiología aislada.

Se inicia manejo con VMNI y terapia ATB de 2da línea (piperacilina/tazobactam) dado antecedente de reciente tratamiento ATB con ceftriaxona. Paciente evoluciona de forma favorable, el 27/10 se logra ventana, tras lo cual no requiere reconexión y se mantiene con oxigenoterapia por NRC. Dada evolución favorable, se decide traslado a HSJM para continuar manejo y completar terapia ATB.

Fecha Epicrisis : 17/11/2022 09:34

Página 1 de 3

En HSJM completa 7 días de ATB el 01/11 y se progresa en destete de oxígeno. Sin embargo, el día 08/11 inicia nuevo cuadro caracterizado por peak febriles, compromiso de conciencia (somnolencia) y aumento de requerimientos de O2, con aumento de la PCR. Es derivado a SU CASR, donde se describe paciente en regulares condiciones generales, en sopor superficial, desorientado, inatento. Al examen físico destaca afebril, pero con requerimientos de O2 (1-2 L NRC sat 87%), con MP global y levemente disminuido, con roncus difusos.

Exámenes de ingreso:

-Hb 15.0, Gb 11.690, RAN 10.000, Plq 239000, PCR 94.6
-BUN 29, Na 140, K 4.9, Cl 101
-GSA: pH 7.33, pCO2 62.4, pO2 27.7, HCO3 31.9
-Alb 2.8, Prot T 7.5, Gluc 217, LDH 268
-TP 89% INR 1.06 TTPA 26.6s

-Panel Viral Respiratorio (-), PCR COVID (-)

-Angio TAC Tx: negativo para tromboembolismo pulmonar agudo. Signos de edema intersticial - alveolar pulmonar. Atelectasias subsegmentarias bibasales. Leve cardiomegalia.

Se inicia manejo de EPOC exacerbado y se hospitaliza en UTIM para continuar estudio y manejo.

Diagnósticos de ingreso:

-EPOC exacerbado
- Obs NAAS

-Hiperglicemia no CAD no SHH

-Insuficiencia renal aguda sobre ERC

-Antecedentes: EPOC no usuario de O2 dom, DM2 IR, Demencia, Hospitalización reciente por EPOC exacerbado (alta 21/10)

Evolución:

- Respiratorio - infeccioso: por hipercapnia de ingreso se conecta a VMNI, además de iniciar corticoterapia y antibioterapia sistémica (tazonam) con broncodilatación, recuperando. Al estudio microbiológico no invasivo: PCR Covid negativa, Panel viral negativo.

- Metabólico: Paciente con DM2 IR usuario de 42 UI NPH + 12 UI glargina para correccional. Ingresa con hiperglicemia acentuada, sin criterios de CAD o SHH que se maneja con rescates de insulina. Se solicita HbA1c, en 8.8. Tras retiro de terapia corticoesteroidal, mejor control de glicemias.

- Nefrológico: Antecedente de ERC, cursando AKI obs prerrenal al momento del ingreso. Con volemicación presenta mejoría, con crea en 1.79 al alta, impresiona en su basal. Sin urgencia actual de ampliar estudio de ERC, plan de hacerlo de manera ambulatoria.

Paciente evoluciona de forma favorable. Intercurrencia infecciosa resuelta y sin requerimientos de O2, en condiciones de alta.

Diagnósticos de alta:

-EPOC exacerbado

-Hiperglicemia no CAD no SHH resuelta

-Insuficiencia renal aguda sobre ERC, resuelta obs pre renal

Fecha Última Actualización: 17-11-2022 9:34:16

Página 3 de 3

-Antecedentes: EPOC no usuariode O2 dom, DM2 IR, Demencia, Hospitalización reciente por EPOC exacerbado (alta 21/11)

Diagnóstico de Egreso

EPOC exacerbado -
Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, sin fiebre, sin requerimientos de oxígeno. Presenta buena tolerancia oral, deposiciones y diuresis diaria, deambulando sin problemas. En condiciones clínicas adecuadas para continuar su terapia y estudio de forma ambulatoria.

Plan Post Alta

GENERALES

Reposo relativo

Régimen bajo en sodio (menos de 2 g al día), bajo en potasio, bajo en fósforo y bajo en carbohidratos.

Insulina según esquema habitual

FÁRMACOS

Paracetamol 1 g c/8 hrs VO x 3 días

Citalopram 20 mg c/24 hrs VO

Memantina 10 mg c/24 hrs VO

Donepezilo 5 mg c/24 hrs VO

Omeprazol 20 mg c/24 hrs VO

Bromuro de ipratropio 2 puff / 8 h x 3 días x aerocámara

Salmeterol /fluticasona 2 puff / 12 h por aerocámara

CONTROLES

Control con Broncopulmonar para optimizar manejo de EPOC, pedir hora con epicrisis a la brevedad.

Control en APS para terapia diabética

Consultar en el Servicio de Urgencias en caso de fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, compromiso de conciencia, dolor intenso que no ceda con analgesia, dificultad respiratoria, sangrado o cuando estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Sebastian Andres Larrain Ca
Becado/Residente

Pablo Sandoval Ramirez
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 17/11/2022 09:34

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:53

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar